

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心房中膈缺損 Atrial Septal Defect; ASD				
編號	A31000-Q03-W-N01	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.1 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解心房中膈缺損的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

心房中膈缺損主要為心房中膈不正常的開口，血液會由左向右分流，使左、右心室有不正常的血液交通，兒童多半無明顯症狀，但可能演變為肺高壓及充血性心衰竭。

（二）症狀

症狀的出現決定於缺損的大小，且生長發育大多為正常體型偏瘦小，缺損小者無症狀，缺損大者症狀出現較早，例如：心悸、呼吸急促、容易疲倦、反覆性呼吸道感染。嬰兒時期因左、右心室壁的厚度差距不大，左、右心室舒張期的充盈阻力差比年長者小，分流不致於過大，所以臨床上表現較少。

（三）常見檢查

1. 胸部 X-ray：右心房及心室肥大，肺血管紋增加。
2. 心電圖：右心室擴大反應於心軸偏右及不完全右支傳導阻滯，右心房擴大則 P 波變高。
3. 心臟超音波(cardio echo)：可見心房中膈缺損且清楚看見位置及大小。

主題名稱	心房中膈缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/9

4. 心導管：可發現右心房的血氧較腔靜脈高，但此並無特異性。

（四）常見治療

1. 內科治療

一般需用強心劑及利尿劑，也需限制活動及限水，對於較大兒童之居家照顧，需衛教家屬採低鈉飲食，以免增加右心負擔，當患者懷孕或服用避孕藥時會加速肺動脈病變，故女性患者不宜延遲手術。

2. 外科治療

(1) 傳統手術:對於未能自行關閉的心房中膈缺損，建議學齡期開刀，在外科手術方面兒童在完全麻醉下將胸骨鋸開，經低溫及心肺繞道術，於無血直視下切開心臟，利用達克隆片(Dacron patch)進行修補以矯正先天畸型。

(2) 微創心房中膈缺損修補術：在內視鏡的協助下，由右側胸腔，以極小的傷口來完成心房中膈缺損修補手術；病人可以維持胸骨的完整性、減少手術後的疼痛、降低肺功能的傷害。

3. 最新療法

安普拉茲心房關閉器(Amplatzer)，為心導管治療中採全身麻醉或局部麻醉，經由股靜脈把心房關閉器(Amplatzer)沿著導管送至心房中膈缺損處，依序將左心房及右心房張開，經由食道心臟超音波協助確定位置後，再放置 Amplatzer，術後需平躺臥床 6-8 小時，行 Amplatzer 心導管治療需具備下列條件：

- (1) 年齡：依醫師追蹤病人超音波報告判斷。
- (2) 為第二型心房中膈缺損且直徑在 2.5 公分以下。
- (3) 右心血液負荷是左心的 1.5 倍以上，且無肺動脈高血壓的病人。

（五）護理問題

1. 心肺血流不足／疾病造成心肺血液灌流異常。
2. 易感染／手術。
3. 無法有效呼吸／肺部擴張減少。
4. 焦慮感受／與接受手術治療。

主題名稱	心房中隔缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/9

(六)護理措施

1. 心肺血流不足／疾病造成心肺血液灌流異常

- (1) 每小時測量生命徵象並報告異常現象。
- (2) 監測血液動力學：中心靜脈壓、肺動脈壓、心輸出量。
- (3) 監測到異常心音、呼吸音時應通知醫師。
- (4) 監測血中氧氣濃度是否足夠。
- (5) 監測末梢循環是否發紺、水腫。
- (6) 教導病人及家屬相關心肺危險因素。
- (7) 教導病人及家屬注意治療藥物的作用及副作用。
- (8) 依醫囑給予利尿劑並監測治療效果。
- (9) 依醫囑給予心肌收縮劑並監測治療效果。

2. 易感染／手術

- (1) 接觸所有病人前後洗手。
- (2) 每小時測量生命徵象並報告異常現象。
- (3) 監測可顯示感染的實驗室檢查（如：CBC），並報告異常現象。
- (4) 監測輸液注射部位有無感染情形。
- (5) 監測傷口滲出液之顏色、氣味、性質及癒合情況。
- (6) 密切觀察炎症症狀（如：紅、腫、熱、痛）及徵象（如：發燒、流膿）。
- (7) 每小時擠壓胸管一次，保持胸管通暢並注意胸管引流液之性質、顏色及量，並指導病人及／或主要照顧者引流管勿高於穿刺部位，維持引流管通暢性及密閉性（侵入性）。
- (8) 避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。
- (9) 執行侵入性治療，採無菌技術執行。
- (10) 視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。
- (11) 評估病人營養狀況，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素飲食以促進傷口的修復再生。

主題名稱	心房中隔缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/9

(12) 指導病人及／或主要照顧者感染的危險因子（如：接觸病人前未洗手、傷口敷料滲濕、濫用藥物、衛生習慣差、營養不良、現存或潛在性疾病）。

(13) 指導病人及／或主要照顧者預防感染的方法（如：接觸病人前後洗手、限制訪客、保持傷口清潔及乾燥，避免壓迫傷口、正確用藥、注意衛生、營養充足等），並評估其瞭解的程度。

3. 無法有效呼吸／肺部擴張減少

- (1) 聽診呼吸音及評估兩邊胸廓是否對稱。
- (2) 監測呼吸道分泌物的顏色、性質、量，並記錄之。
- (3) 協助採最佳臥姿（如：坐臥、半坐臥），獲得足夠換氣和氧合狀況。
- (4) 執行胸腔物理治療時（如：胸部叩擊、震顫、姿勢引流），予以支托手術傷口，並協助每兩小時翻身及拍背叩擊，以刺激痰液排出，必要時給予抽痰。
- (5) 指導咳嗽時壓住傷口，避免過度震動，引起傷口疼痛。
- (6) 監測組織缺氧的徵象（如：心智狀況改變、心跳過速、頭痛、發紺、易怒和異常呼吸音），並報告醫師。
- (7) 依醫囑給予氧氣治療，並鼓勵深呼吸。
- (8) 依醫囑給予藥物治療（如：支氣管擴張劑、祛痰劑），並評估藥效、副作用及病人反應。

4. 焦慮感受／接受手術治療

- (1) 瞭解病人或家屬害怕焦慮的原因，協助解決。
- (2) 瞭解病人或家屬是否有任何擔心或憂鬱的事，予以傾聽和支持。
- (3) 請醫師解釋手術過程，減輕病人或家屬的焦慮。
- (4) 詳細的手術前衛教（包括靜脈導管之插入、等待室之環境、轉送過程、以及手術後運動），以減輕焦慮。
- (5) 介紹接受相同手術病人給予認識，彼此交換意見，減輕焦慮。
- (6) 小兒手術前給予衛教，可促使孩童表現出較為合作的態度，減低其焦慮情形。
- (7) 請家屬或有意義的人陪伴，增加安全感。

主題名稱	心房中隔缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/9

(8) 予治療性觸摸（包括觸摸、按摩、撫觸），減輕焦慮程度。

(七)衛教指導

1. 小兒心導管檢查前後須知。
2. 發燒的處置。
3. 拍背。
4. 噴霧吸入療法。
5. 心臟病童的居家照顧。

(八)實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）方妙君、杜玲、林韋君(2023)・心臟血管系統疾病病人之護理・於陳夏蓮總校閱，內外科護理學（七版，401-542 頁）・華杏
- （二）邱雅鳳、陳碧君(2022)・提高加護病房心臟手術病人術前護理指導完整率專案・領導護理，23(1)，115-129。
- （三）呂鴻基、沈慶春、王主科、吳美環、吳俊明、....花玉娟等(2021)・兒童心臟學（二版）・台北市：金名圖書。
- （四）陳月枝、黃靜微、林元淑、張綠怡、蔡綠蓉、林美華...魏琦芳(2021)・實用兒科護理學（9 版）・台北市：華杏。

主題名稱	心房中隔缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/9

七、附件

(略)

主題名稱	心房中隔缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容的錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.8.31	2.2	修改說明內容的錯別字及新增文獻	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	刪除：心導管治療條件年齡最好三歲以上修改為二歲以上。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	說明內容部份修辭	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.3	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.4	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.5	增修第六項參考文獻資料	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.6	新增第六項第六目參考文獻資料。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過

主題名稱	心房中隔缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
108.09.23	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 3. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 第六項文獻參考資料更新。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.8	1. 修訂第三項第五、六目護理問題。 2. 更新第六項文獻參考資料。 3. 刪除內文參考文獻。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.9	更新第六項文獻參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	4.0	第三項第六目說明內容部份刪除。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過;113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.1	1.新增第三項說明內容之常見治療。 2.第六項文獻參考資料更新	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	心房中隔缺損	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N01	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註